

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

PROCEDURA OPERATIVA GESTIONE FARMACI NEI CENTRI MEDICI E NEI PUNTI PRELIEVO

Area 17 – Accettazione

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-PRO052_00	00	15/04/2026	10
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
DS / Retail / RSGI	AD – Francesco Epifani	Interno	In vigore

Rif.: D.Lgs. 219/2006 · D.P.R. 309/1990 (stupefacenti) · Raccomandazioni Min. Salute nn. 1, 7, 12, 18 · R.D. 1706/1938 art. 37 · D.P.R. 254/2003 (rifiuti sanitari) · Farmacopea Ufficiale IX ed. · ISO 9001 cl. 8.5 · TD-SGI-PRO051 (Attività di Prelievo) · TD-SGI-IDL015 (Accettazione) · TD-SGI-MOD069 (Check List Carrelli Emergenza) · TD-SGI-MOD072 (Registro Temperature) · TD-SGI-PRO036 (Magazzino: FEFO)

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Silvia Sansoni	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
27/04/2026	27/04/2026	27/04/2026

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

1. Scopo e campo di Applicazione

Questa procedura ha lo scopo di:

- descrivere il processo di gestione clinica dei farmaci, dei vaccini, dei presidi sanitari, dei dewar di azoto liquido e dei gas medicali presenti in Azienda (Punti Prelievo e Poliambulatorio);
- prevenire il verificarsi di eventi avversi dovuti ad un uso non corretto dei farmaci nell'ambito dell'assistenza sanitaria con particolare riferimento agli eventi correlati all'impiego di farmaci considerati ad "alto rischio";
- fornire indicazioni per il corretto approvvigionamento e conservazione dei prodotti farmaceutici.

2. Termini e Definizioni

- **DOSAGGIO**: quantità di principio attivo presente in un'unità posologica (es. compressa, fiala, ecc.).
- **DOSE**: quantità di un farmaco necessaria per conseguire, con la sua somministrazione, un determinato effetto farmacologico.
- **FARMACO**: qualsiasi sostanza inorganica o organica naturale o sintetica, capace di produrre in un organismo vivente modificazioni funzionali, utili o dannose, mediante un'azione chimica, fisica o chimico-fisica.
- **FARMACOVIGILANZA**: La farmacovigilanza consiste in tutte quelle attività legate alla scoperta, alla valutazione, alla comprensione e alla prevenzione degli eventi avversi e di altre problematiche derivanti dall'assunzione di farmaci.
- **FARMACI LASA (Look Alike/Sound Alike)**: acronimo utilizzato per indicare quei farmaci che possono essere facilmente scambiati con altri per somiglianza grafica e/o fonetica del nome e/o per l'aspetto simile delle confezioni. La somiglianza può riguardare:
- il principio attivo, il nome commerciale di un farmaco o la loro combinazione, nel numero di caratteri o suoni simili in comune alle due parole, quando i nomi vengono scritti (somiglianza ortografica: Look alike), o quando vengono pronunciati/ascoltati (somiglianza fonetica: sound alike)
- il confezionamento (somiglianza nel confezionamento per forma, dimensione, colore, indicazione del dosaggio e disposizione dei caratteri: Look alike).
- **PRINCIPIO ATTIVO**: componente essenziale di un farmaco dotata di attività farmacologica.
- **CONTRAFFAZIONE**: imitazione di un prodotto, mediante la replica non autorizzata del prodotto originale. La contraffazione è prodotta per ottenere vantaggi economici commercializzando il prodotto a prezzo ridotto, e con materiali inferiori, rispetto all'originale.

3. Riferimenti

1. R.D. 30 settembre 1938, n. 1706 "Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico", art.37.
2. Decreto del Presidente della Repubblica 15.07.2003, n. 254: "Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari", a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n.179.
3. D.M. 18 novembre 2003 "Procedure per l'allestimento in farmacia di medicinali non sterili in scala ridotta", Ministero della Salute. Commissione tecnica sul rischio Clinico (DM 5/3/2003): "Risk management in Sanità. Il problema degli errori." Marzo 2004.
4. D.M. 22 giugno 2005 "Procedure di allestimento in farmacia di preparazioni magistrali e officinali".
5. Ministero della Salute. Dipartimento della Qualità Ufficio III: "Sicurezza dei pazienti e gestione del rischio clinico: Manuale per la formazione degli operatori sanitari". Settembre 2007.
6. D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti
7. Ministero della Salute. Dipartimento della Qualità Ufficio III: "Sicurezza dei pazienti e gestione del rischio clinico: Manuale per la formazione dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Famiglia". Marzo 2010.

8. Ministero della Salute. Dipartimento della Qualità Ufficio III - Raccomandazione n.1 di marzo 2008 "Raccomandazione sul corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di cloruro di potassio – KCl – ed altre soluzioni concentrate contenenti potassio".
9. Ministero della Salute. Dipartimento della Qualità Ufficio III - Raccomandazione n.7 di marzo 2008 "Raccomandazione per la prevenzione della morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia farmacologica
10. Ministero della Salute. Dipartimento della Qualità, Ufficio III - Raccomandazione n° 12 di agosto 2012 "Raccomandazione per la prevenzione degli errori in terapia con farmaci Look-alike/Sound-alike".
11. Ministero della Salute. Dipartimento della Qualità, Ufficio III - Raccomandazione n° 18 di settembre 2018 "Raccomandazione per la prevenzione degli errori in terapia conseguenti all'uso di abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli".
12. Sito OMS: http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/en/index.html
13. Farmacopea Ufficiale "Norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia", 9° edizione
14. Ismp's List Error Prone Abbreviations, Symbols, and Dose Designations (ISMP)

4. Responsabilità

La Direzione Sanitaria ha la responsabilità di:

- mettere in atto misure di gestione clinica e di corretto utilizzo dei farmaci;
- vigilare sull'applicazione delle azioni pianificate;
- approvvigionare le scorte dei farmaci utilizzati dai medici;
- verificare l'applicazione della procedura da parte degli operatori.

Il Medico Specialista del Centro Medico ha la responsabilità di:

- provvedere al monitoraggio farmacologico segnalando alla farmacovigilanza le eventuali reazioni avverse;
- preparare la terapia farmacologica;
- somministrare la terapia farmacologica.

Gli Infermieri hanno la responsabilità di:

- custodire la chiave per l'accesso all'armadio farmacia;
- distribuire i farmaci/materiali negli ambienti di lavoro;
- approvvigionare le scorte;
- smaltire i materiali scaduti/non utilizzabili;
- adottare le corrette modalità di conservazione per farmaci e presidi sanitari;
- mantenere aggiornato l'elenco dei farmaci in uso nella struttura in collaborazione con i medici referenti di branca;
- effettuare un controllo quali-quantitativo tra quanto ricevuto e quanto ordinato;
- ricevere i prodotti nei tempi previsti;
- verificare le modalità di conservazione e stato del materiale inviato (es.: mantenimento della catena del freddo (in particolare per i vaccini), integrità delle confezioni, corretta etichettatura, consegna dei prodotti nelle confezioni originali, ecc.);
- controllare periodicamente le scadenze e lo stato di conservazione dei prodotti farmaceutici secondo un piano specifico;

I referenti del Dipartimento Health, Quality & Safety devono:

- verificare che i moduli e le procedure siano aggiornati e correttamente gestiti;
- svolgere periodici audit nelle aree di stoccaggio.

5. Gestione Farmaci e Presidi Sanitari

5.1 Tipologie dei farmaci

I farmaci, le soluzioni infusionali, gli antisettici, i disinfettanti e i vaccini sono scelti dalla Direzione Sanitaria su proposta dei Medici Specialisti e vengono indicati nel prontuario farmaceutico interno (PFI). Questo documento è periodicamente aggiornato dal Direttore Sanitario in collaborazione con gli specialisti che fanno uso di questi farmaci ed essendo uno strumento di lavoro comune deve essere sempre disponibile per la consultazione presso l'ufficio del Direttore Sanitario. Nella scelta dei farmaci si preferiscono, per quanto possibile, quelli di facile identificazione, limitando, per quanto possibile, farmaci che per confezionamento, dosaggio, pronuncia e scrittura (farmaci LASA: look alike/sound-alike) possono favorire lo scambio tra farmaci simili. I farmaci possono essere classificati in:

- Farmaci registrati dal Ministero della Salute e in Commercio, il loro utilizzo è ammesso limitatamente alle indicazioni autorizzate nella scheda tecnica di ognuno di essi e comprendono farmaci indicati in Prontuario e di uso abituale e sostanze stupefacenti e psicotrope;
- Campioni di specialità medicinali: il loro uso può avvenire esclusivamente nei limiti del D.lgs 219/2006 che prevede che essi vengano consegnati dal Produttore solo su richiesta scritta del singolo medico, che diviene direttamente responsabile della loro conservazione ed impiego. Pertanto, i campioni non possono trovare allocazione né nell'armadio farmaceutico né sui carrelli di terapia, né negli studi medici della struttura; eventuali campioni rinvenuti giacenti in struttura saranno smaltiti secondo le modalità di legge e le procedure di Sistema.

5.2 Tipologie delle confezioni

I medicinali ed i dispositivi medici devono essere conservati nelle confezioni originali, che sono le più idonee a prevenire alterazioni e che indicano:

- le modalità di conservazione e d'uso;
- la data di preparazione e di scadenza;
- i dosaggi, modi e tempi di conservazione;
- il numero del lotto, importante per un eventuale richiamo di prodotto e/o tracciabilità dello stesso.

5.3 Schema delle temperature di conservazione dei farmaci

Una linea guida comunitaria definisce quanto deve essere riportato nell'etichetta di un prodotto medicinale in relazione alla temperatura di conservazione, precisando che tutti gli operatori sono tenuti al rigoroso rispetto delle condizioni di conservazione indicate. Nella pratica si possono avere le seguenti situazioni:

Temperatura	Modalità di conservazione
Nessuna indicazione	Se in etichetta non vengono riportate indicazioni particolari si consiglia di conservare tali prodotti tra 8 - 25°C.
2 - 8°C	Richiede la conservazione in frigorifero. I farmaci da conservare a temperatura ottimale vicina a 2°C devono essere posti in alto vicino allo scomparto ghiaccio del frigorifero, quelli con temperatura ottimale vicina a 8°C vanno posti nella parte bassa del frigorifero. Per una corretta conservazione dei farmaci è importante non riempire eccessivamente il frigorifero prestando attenzione a non accostare i farmaci alle pareti. La temperatura dei frigoriferi in cui sono stoccati i vaccini deve essere verificata due volte al giorno. L'operatore sanitario deve verificare le temperature di massima e minima registrate dal termometro presente nel frigorifero. N.B. La temperatura del frigorifero non deve mai scendere al di sotto dei 2°C per evitare l'alterazione di alcune tipologie di prodotti.

< 25°C e/o <30°C	La conservazione dei farmaci a tale temperatura può risultare problematica solo nella stagione estiva. È pertanto consigliabile: • evitare in ogni caso l'esposizione a irradiazione solare o ad altre fonti di calore; • conservare modiche quantità di farmaci da rinnovare di frequente; • se la temperatura ambiente permane superiore a quella indicata, conservare nella parte inferiore del frigorifero.
- 20°C	La conservazione in congelatore è indicata per un numero limitato di prodotti e deve essere rispettata con particolare rigore.

5.4 Campioni di medicinali gratuiti

La detenzione dei farmaci contrassegnati come “campioni medicinali gratuiti”, non è consentita in alcun caso, a norma dell'art. 13 (D. Lvo. 541/92). Pertanto, qualsiasi campione gratuito rinvenuto deve essere eliminato. Il Coordinatore e il personale infermieristico provvederanno al controllo periodico degli studi medici onde verificare che non vi siano giacenti farmaci contrassegnati dalla dicitura “campione medicinale gratuito” e/o comunque preparati farmaceutici o dispositivi medici che non siano stati acquistati e dispensati secondo le procedure normali di approvvigionamento.

6. Descrizione delle attività

6.1 Richiesta di farmaci e presidi sanitari

Le richieste dei farmaci sono effettuate sulla base dell'utilizzo e delle prescrizioni effettuate dai Medici Specialisti e devono assicurare la presenza della tipologia e dei quantitativi di farmaci necessari per la corretta somministrazione delle terapie prescritte. Qualora ci fosse la necessità di ordinare farmaci o presidi sanitari, il personale sanitario provvede ad effettuare la richiesta al Responsabile Infermieristico, inviando una e-mail con i dettagli dell'ordine riportanti il nome commerciale del farmaco, la quantità e se la richiesta ha carattere di urgenza.

6.2 Richiesta di nuovi farmaci

La richiesta di inserire in prontuario nuovi farmaci deve essere effettuata dal Medico Specialista alla Direzione Sanitaria, che approva la richiesta in relazione alla motivazione clinica ricevuta ed alla valutazione dei costi e dei rischi.

6.3 Ricezione e presa in carico dei farmaci

Il coordinatore infermieristico o altro infermiere da lui delegato, all'arrivo dei farmaci richiesti, deve:

- effettuare un controllo qualitativo-quantitativo tra quanto ricevuto e quanto ordinato;
- controllare che i prodotti siano stati consegnati nei tempi concordati;
- verificare le modalità di conservazione e lo stato del materiale inviato (es.: mantenimento della catena del freddo (in particolare alla consegna dei vaccini), integrità delle confezioni, consegna dei prodotti nelle confezioni originali, ecc...);

6.4 Stoccaggio, conservazione farmaci e presidi sanitari

Lo stoccaggio dei farmaci si trova presso i frigoriferi e gli armadi, dove sono custoditi tutti i farmaci che vanno poi a rifornire le zone di cura. L'armadio farmacia è chiuso a chiave con accesso SOLO a personale infermieristico autorizzato. Altri farmaci sono disposti nel carrello delle emergenze la cui ubicazione è indicata nella procedura della gestione delle emergenze. La conservazione dei farmaci

e dei materiali sanitari deve avvenire nel rispetto delle norme igieniche standard e di quelle ambientali (temperature, luce, umidità) richieste e specificate sulle etichette dei diversi prodotti.

Non è quindi ammesso collocare direttamente sul pavimento farmaci e materiali sanitari anche se in contenitori secondari (scatole). Si raccomanda di non lasciare mai scatole posizionate a terra. Gli armadi destinati ai materiali di interesse farmaceutico devono essere chiusi a chiave e posizionati in ambienti accessibili al personale sanitario ma non accessibili a personale non autorizzato. Devono essere sistemati tenendo conto dei fattori che interferiscono con una buona conservazione (in particolare calore e umidità), evitando di stoccare farmaci in aree a ciò non specificatamente adibite (es. sgabuzzini, cucina). È inoltre necessaria una sistematica e frequente pulizia, norma elementare di igiene sanitaria. La gestione attenta e costante dell'armadio farmaceutico è un presupposto essenziale per una sicura assistenza al paziente. In tale prospettiva è fondamentale:

- evitare mescolanze di contenuti (es. farmaci con altri materiali);
- prevedere la separazione fisica tra medicinali, dispositivi medici, disinfettanti e diagnostici;
- prestare particolare attenzione allo stoccaggio del KCl che dovrà essere conservato in luogo separato indicando la dicitura "mortale se non diluito", come da raccomandazione ministeriale;
- prestare attenzione allo stoccaggio dei farmaci LASA (Look Alike/Sound Alike), come da raccomandazione ministeriale;
- le medicazioni con iodofornio devono essere conservate in un contenitore chiuso (al riparo dalla luce) in luogo fresco, preferibilmente su scaffale. Infatti, essendo lo iodofornio volatile, esso può saturare l'aria di armadi o cassette ed essere assorbito da altri dispositivi medici presenti, compresi i materiali in plastica sterili confezionati in busta;
- conservare tutti i prodotti nelle confezioni originali e con relativo foglietto illustrativo; nel caso in cui sia indispensabile lo sconfezionamento, è opportuno etichettare la nuova confezione indicando tutti gli estremi utili al riconoscimento, alla conservazione, all'uso e alla identificazione della scadenza; disporre di materiali secondo un ordine prestabilito noto a tutti gli operatori sanitari. Per i farmaci, ad esempio, può essere utilizzato l'ordine alfabetico, preferibilmente accompagnato dalla suddivisione per forma farmaceutica o per categoria terapeutica;
- nel riporre farmaci e altri materiali è importante posizionare in evidenza prodotti con scadenza più ravvicinata; si devono fare ruotare le confezioni in modo da collocare davanti quelle con scadenza ravvicinata e, comunque, quelle giacenti da più tempo;
- evitare scorte eccessive che comportano spreco di risorse e difficoltà di stoccaggio e di verifica, con conseguente rischio di scadenza.

Nei carrelli della terapia e delle medicazioni in uso devono trovare posto esclusivamente i prodotti di volta in volta in uso e di quelli di uso frequente. Il controllo delle scadenze di questi materiali viene eseguito mensilmente dagli infermieri. I prodotti infiammabili sono conservati in apposito armadio o locale al riparo da fonti di calore e da combustibili.

6.5 Conservazione in frigorifero

È importante ricordare che i farmaci ed altri materiali da conservare a temperature particolari devono essere posti alle condizioni per essi indicate sulla confezione al momento della consegna, che viene effettuata in busta termica o con segnalazione sul pacco "farmaci 2/8 °C". Il frigorifero utilizzato deve essere adibito esclusivamente ai farmaci. La conservazione di un farmaco ad una temperatura differente da quella indicata può comportare, a seconda dei casi, perdita totale o parziale di attività e/o interazioni che possono essere critiche soprattutto per prodotti ad elevata attività farmacologica. Nel caso in cui si verificassero problemi di conservazione (es. rottura del frigorifero) è sempre obbligatorio, prima di eliminare e/o usare i medicinali coinvolti, segnalare l'accaduto al Direttore Sanitario che, dopo le idonee verifiche, potrà dare indicazioni documentate sul modo più opportuno di procedere. Per garantire una buona conservazione si consiglia di:

- verificare che durante il trasporto sia stato rispettato il mantenimento della catena del freddo e al momento del ricevimento, deve essere effettuato l'immediato trasferimento in frigorifero;
- evitare di addossare le confezioni dei farmaci alla parete del frigorifero (rischio di congelamento);

- non lasciare aperta a lungo la porta del frigorifero;
- non mettere in frigorifero farmaci per i quali non è previsto questo tipo di conservazione (c'è il rischio di alterare le caratteristiche del prodotto, ad es. aumenta la fragilità delle compresse o ci può essere l'assorbimento dell'umidità, etc.). Quindi verificare ad ogni carico se l'etichetta del prodotto riporta indicazioni in merito alla temperatura di conservazione; talvolta, infatti anche per prodotti in uso da tempo, per problemi di natura tecnologica, possono cambiare le condizioni di conservazione consigliate;
- verificare giornalmente la corretta funzionalità del frigorifero, con le modalità in uso presso la Toscana Diagnostica. Se le temperature registrate sono fuori dai range stabiliti l'operatore deve avvisare il Direttore Sanitario.

Le temperature dei termometri posizionati nei frigoriferi in cui sono stoccati i vaccini devono essere verificate due volte al giorno (ad intervalli non superiori alle 12 ore).

Se la temperatura registrata è fuori dai range stabiliti, l'operatore deve avvisare il Direttore Sanitario e procedere all'eliminazione dei vaccini stoccati.

6.6 Gestione scadenze farmaci e presidi sanitari

Il controllo e la conservazione dei farmaci, dei vaccini e dei presidi sanitari sono responsabilità degli infermieri e di tutto il personale sanitario. È necessario effettuare la verifica delle scorte ed il controllo delle scadenze dei farmaci ordinari e dei materiali di consumo in dotazione. Il controllo della scadenza si esegue verificando le apposite indicazioni presenti sulle confezioni dei prodotti farmaceutici. In mancanza dell'indicazione del giorno, la data di scadenza corrisponde all'ultimo giorno del mese indicato per la scadenza. Se si tratta di un farmaco MONODOSE, questo può essere utilizzato una sola volta e per un singolo paziente. Ciò significa che una volta aperta la confezione di un farmaco monodose non può essere più utilizzata. Anche nel caso in cui si utilizzi solo una piccola parte del contenuto della confezione monodose tale confezione deve essere comunque cestinata. Se si tratta di un farmaco MULTIDOSE o di pomate e flaconcini, questi possono essere utilizzati più volte anche per pazienti diversi. Pertanto, una volta aperta la confezione sulla stessa dovrà essere scritta, con penna o pennarello indelebile, la data di apertura (di primo utilizzo) e la nuova scadenza. La data di validità dalla prima apertura di ogni singolo prodotto multidose è stabilita secondo quanto scritto sul bugiardino di ogni singolo farmaco. In assenza di dati nella scheda tecnica, la scadenza dalla data di apertura è stabilita in accordo con il Direttore Sanitario. I farmaci devono essere smaltiti secondo quanto indicato dalla normativa vigente. I disinfettanti vengono conservati in magazzino e al momento dell'apertura viene indicata, direttamente sul contenitore del prodotto, con pennarello indelebile, la data di apertura e la data di scadenza. Quando viene aperta l'ultima confezione il personale sanitario comunica al Responsabile Infermieristico la necessità di effettuare un nuovo ordine.

6.7 Somministrazione

La responsabilità della somministrazione dei farmaci è del Medico Specialista del Poliambulatorio o dell'Infermiere che esegue la terapia, secondo il prospetto terapeutico indicato in cartella e nel foglio di terapia siglato dal Medico di reparto o curante. L'operatore provvede personalmente, nei tempi previsti alla somministrazione, al prelievo dei farmaci dalle confezioni originali, a predisporli per la somministrazione ed a somministrarli.

Nella manipolazione dei farmaci si deve tenere conto delle specifiche indicazioni, riportate nei foglietti illustrativi, quali:

- i farmaci ad uso topico, quali gocce, colliri, pomate oculari, sono ad uso strettamente personale; sulle confezioni deve essere scritto il nome del paziente e la data di apertura della confezione;
- i farmaci che vanno conservati in frigorifero devono essere prelevati al momento e, quando sono in confezioni multi-dose, vanno riposti in frigorifero immediatamente dopo l'utilizzo con l'avvertenza, dopo l'eventuale apertura della confezione, di rispettare i tempi limite e le modalità di

conservazione indicate sul foglietto illustrativo. La somministrazione deve avvenire solo dopo che sia trascorso un tempo adeguato al “riscaldamento” onde evitare di somministrare preparati a temperatura non idonea con quella corporea con la possibilità di suscitare reazioni indesiderate;

- non si devono lasciare farmaci in consegna ai pazienti o ai famigliari.

7. Farmaci Stupefacenti

Il Direttore Sanitario è responsabile della tenuta e vidimazione all'Ente competente del registro degli stupefacenti. Provvede, inoltre, al controllo periodico delle giacenze, agli ordini di acquisto dalla farmacia esterna, e sovrintende alla gestione degli stupefacenti nella struttura secondo le normative vigenti. È responsabile della conservazione dei modulari esauriti per due anni dall'ultima trascrizione per le richieste di approvvigionamento e per i registri di carico e scarico, e cinque anni per quelli di restituzione.

7.1 Carico e scarico delle sostanze stupefacenti nel servizio di Endoscopia

Il personale di reparto segnala la necessità di approvvigionamento alla Direzione Sanitaria; il Direttore Sanitario compila la richiesta scritta in triplice copia. La richiesta deve essere inoltrata in formato elettronico e in modalità cartacea alla Farmacia. Alla consegna i farmaci sono accompagnati da una bolla e da una copia della richiesta. Il Personale Sanitario che riceve i farmaci deve registrarne l'arrivo nel registro stupefacenti. Ogni acquisto deve essere iscritto in un registro speciale denominato “registro entrate e uscita sostanze psicotrope e stupefacenti” vidimato dal Direttore Sanitario nel quale, secondo un'unica progressione numerica, deve essere tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle sostanze predette. Il Personale Sanitario rileva dalla farmacia fiduciaria le sostanze ordinate e provvede alla trascrizione dei quantitativi in entrata sul registro, in accordo con il Direttore Sanitario, controfirma la registrazione di carico e provvede a stoccare gli stupefacenti nell'apposita cassaforte. Ciascuna pagina del registro deve essere intestata ad una sola preparazione e annotata la destinazione e la quantità del farmaco distribuito alle unità operative. Tale registro generale di carico e scarico è numerato e firmato in ogni pagina dall'autorità competente che dichiara nell'ultima il numero delle pagine da cui il registro è costituito.

Approvvigionamento interno:

Il personale infermieristico, su appositi moduli, fa richiesta alla Direzione Sanitaria della quantità necessaria di preparazioni e ne predispone il rifornimento.

Il personale deve attenersi alle norme d'uso di seguito riportate:

- Il registro deve essere vidimato in ogni sua pagina già pre- numerata dal Direttore Sanitario che ne provvede la distribuzione;
- I Coordinatori sono incaricati della buona conservazione del registro, che deve essere conservato per due anni dalla data dell'ultima registrazione;
- Il Direttore Sanitario, attraverso ispezioni periodiche, accerta la corretta tenuta del registro di carico e scarico di reparto;
- Il Direttore Sanitario è responsabile dell'effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e reale delle sostanze stupefacenti;
- Ogni pagina del registro deve essere intestata ad una sola preparazione medicinale indicandone la forma farmaceutica ed il dosaggio. Inoltre, si deve indicare l'unità di misura riportata per la movimentazione;
- Le registrazioni, sia in entrata che in uscita, devono essere effettuate contestualmente alla movimentazione, senza lacune di trascrizione dal medico che somministra il farmaco;
- Dopo ogni movimentazione deve essere indicata la giacenza;
- Per le registrazioni deve essere impiegato un mezzo indelebile; le eventuali correzioni, effettuate senza alcuna abrasione e senza uso di sostanze coprenti, dovranno essere controfirmate;
- Nel caso di somministrazione parziale di una forma farmaceutica il cui farmaco residuo non può essere successivamente utilizzato (come, ad esempio, una fiala iniettabile), si procederà allo

scarico dell'unità di forma farmaceutica. Nelle note sarà specificata l'esatta quantità di farmaco somministrata, corrispondente a quella indicata in cartella clinica del paziente. La quantità residua del farmaco deve essere smaltita nei rifiuti speciali:

- Il registro non è soggetto a chiusura annuale;
- Per le prescrizioni d'uso, il personale infermieristico deve fare riferimento a quanto indicato espressamente e chiaramente all'interno del registro;
- I farmaci stupefacenti vengono conservati in cassaforte e consegnati direttamente al personale medico/infermieristico per l'utilizzo.

Le sostanze stupefacenti o psicotrope sono conservate in cassaforte e accessibili solo al personale autorizzato.

8. Materiale per le Emergenze

La fornitura di farmaci e presidi per le emergenze deve corrispondere agli specifici elenchi presenti nei vari servizi. Ad ogni carrello/borsa delle emergenze deve essere allegato il corrispondente elenco con i moduli di controllo redatti, aggiornati e conservati in modo che risulti di facile consultazione. La verifica del controllo giacenze nei carrelli delle emergenze viene effettuata secondo quanto previsto dall'apposita Istruzione di Lavoro. La verifica del contenuto della cassetta di Pronto Soccorso è registrata nell'apposita Scheda.

9. Bombole Gas Medicinali

Le bombole di gas medicali richiedono la conservazione in luoghi sicuri ed areati, al riparo dal sole e lontano da fonti di calore, non accessibili ai pazienti ma ai soli utilizzatori. In particolare, è previsto che le bombole siano legate con catenella, piene, collaudate, non scadute e con manometro in perfetto funzionamento. È necessario verificare la scadenza della bombola e dell'ossigeno contenuto.

10. Antisettici

I prodotti in uso devono essere utilizzati secondo le specifiche del Produttore soprattutto per quanto attiene al tempo minimo indicato per la loro piena efficacia antisettica. Occorre avere cura di non inquinare mai il bordo interno del contenitore e, di conseguenza, il liquido antisettico

11. Vaccini

Il Medico o l'Infermiere, prima di accogliere i pazienti che si devono sottoporre alla vaccinazione, deve controllare la temperatura del frigorifero, i lotti e le scadenze dei vaccini.

Il personale sanitario deve:

- chiamare il paziente in ambulatorio e verificare: nome, cognome e data di nascita;
- procedere con il colloquio informativo durante il quale deve consegnare ai pazienti il materiale informativo specifico;
- verificata la corretta compilazione della documentazione attesa, qualora l'anamnesi non metta in evidenza problemi sanitari di rilievo, è possibile procedere con la vaccinazione;
- al termine della prestazione, consegnare ai Pazienti il certificato di vaccinazione che riporta lotto/data di scadenza del vaccino utilizzato e la firma dell'operatore sanitario che ha eseguito la prestazione.

12. Materiale Sterilizzato

L'involucro del materiale sterilizzato deve essere mantenere la sterilità del materiale fino alla scadenza stabilita. Il Personale Sanitario mensilmente deve verificare con apposito Modulo che

l'involucro sia integro (il materiale deve essere preservato da agenti chimici, fisici, biologici in grado di alterarne le proprietà) e verificare la data di scadenza presente sulla confezione.

13. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione modifiche	Approvazione
00	15/04/2026	Prima emissione SGI (integra e sostituisce PO035 Rev. 1 del 15/04/2025)	Francesco Epifani